

Teekond institutsioonist personaalse taastumise poole



Tuuli Ainsaar, MA

Kogukonnas elamist kasutavad psüühikahäirega inimesed on saanud uued elukohad linnades. Milline on nende argipäev ning kuidas teenus toetab nende suutlikkust ise oma elu korraldada ja kogukonna elus osaleda? Uurimusest selgus, et inimesed vajavad mitmesuguseid toetusmeetmeid, et neist saaksid iseseisvamad kogukonna liikmed, kasutamata on ka kogukondlikud ressursid.

Kogukonda elama asumine on personaalse taastumise teekonna algus – jõudsime sellele järeldusele koos magistritöö juhendaja Dagmar Narussoniga. Mitmes riigis korraldatud uuringud on näidanud, et hoolimata erihoolekandeteenuseid kasutavate psüühikahäiretega inimeste kolimisest asulatest kaugel asuvatest hooldekodudest kogukonda, on nende sotsiaalne kaasatus endiselt madal ning nad puutuvad kokku diskrimineerimise ja tõrjutusega. Ebapiisava toetuse tõttu on asutuses elades passiivseks muutunud inimestel uue elukorraldusega keeruline toime tulla. Osa neist võib isegi sattuda tagasi mõnda institutsiooni, näiteks haiglasse või vanglasse (Primeau jt 2013; Salisbury jt 2016). Seega on oluline, et lisaks keskkonnale muutuks ka teenuse sisu ja olemus. Deinstitutionaliseerimise eesmärgid on võimalik saavutada vaid siis, kui psüühikahäirega inimesele teenuseid pakkudes võetakse omaks mõtlemisviis, mis põhineb

taastumise põhimõtetel ja rehabilitatsiooni nüüdisaegsetel lähenemistel (Wilken jt 2014; William 1993).

Oma uurimuses¹ keskendusin sellele, kuidas Eestis toetatakse kogukonnas elamise teenust kasutavate inimeste osalemist kogukonna elus ja kui palju seejuures järgitakse personaalse taastumise protsessi põhimõtteid. Uurimuse eesmärk oli **mõista teenusekasutajate argipäeva**. Andmeid kogudes vestlesin ühe teenuseüksuse kolme klienditöö spetsialistiga ja vaatlesin teenuse kasutajate ja töötajate igapäevaseid suhtlusrutiine. Järgnevalt tutvustan oma uurimust ja tähelepanekuid.

Deinstitutionaliseerimise taust

Aastakümneid on psüühikahäiretega inimestele pakutud erihoolekandeteenuseid ühiskonnast eraldatud rahvarohketes hooldekodudes. Selle taga oli ühiskondlik

¹ 2018. aastal Tartu Ülikoolis kaitsitud magistritöö „Teekond institutsioonist personaalse taastumise suunas”, juhendaja Dagmar Narusson.

kokkulepe, mille raames rajati tehiskud keskonnad, mis arvestaksid inimeste sarnasustega ja pakusid turvalist, teraapilist ja stabiilset elukeskkonda (Scott 2013). Kuigi eesmärk oli üllas, selgus aja jooksul, et selline teenusekorraldus pole jätkusuutlik ega tõhus. Institutsioonis elamine tähendas muuhulgas kindlaid reegleid ning autonoomia, privaatsuse ja valikute puudumist. Seal kujundasid psüühikahäiretega inimeste elukorraldust organisatsiooni võimalused ja nõuded ning töötaja ja patsiendi suhted, milles võimupositsioonil on töötaja (Jones ja Flowes 2008). Institutsioonis elavad inimesed on eraldunud ühiskonnast, sõpradest ja pereliikmetest, nad ei saa ise otsustada ega valida, kellega nad koos elavad ja tuba jagavad (Bullock ja Mahon 2017).

Uuringutest on selgunud, et selline teenus ei aita psüühikahäirega inimesel haigusega toime tulla ega taastuda. Institutsiooniline elukorraldus muudab psüühikahäiretega inimese passiivseks, sest ta on harjunud tegema vaid seda, mida tal lubatakse või kästakse (Lamb ja Bachrach 2001). Erving Goffmani teooria kirjeldab, kuidas inimene võõrdub reaalsest elust ning käitub vastavalt institutsioonis õpetatule. Tihti kaotab inimene selles olukorras oma elu eesmärgid, usalduse ja kontakti teiste inimestega, oskuse teha valikuid ning käituda vastavalt ühiskonna normidele. Tal pole ka motivatsiooni pingutada oma elu parandamise nimel. Psüühikahäirega inimese haigusest saab institutsioonis tema identiteet (Jones ja Flowes 2008).

Deinstitutsionaliseerimise liikumine sai alguse 1950. aastatel Ameerikas seoses suurte rahvarohkete hooldekodude kahjulikkuse märkamise ja teadvustamisega (Fakhoury ja Priebe 2007). Liikumise põhieesmärk on inimese elukeskkonna normaliseerimine; see rõhutab, et igal inimesel

on enesemääramise ja oma elu kontrollimise õigus (Neufeld 1977). See tähendab, et igale inimesele olenemata tema staatusest, puudest, usust või rahvusest peab olema tagatud elukorraldus, mis on ühiskonnas tavaks: võimalus töötada, õppida, saada osa avalikest teenustest, teha valikuid ja ise otsustada, panustada ühiskonda jne (Nirje 1999). Vaimse tervise valdkonnas on deinstitutsionaliseerimisel kolm põhiülesannet: 1) psüühikahäiretega inimeste viimine hooldekodust ja haiglast kogukonda, 2) psüühikahäiretega inimeste institutsiooni sattumise ennetamine, 3) psüühikahäiretega inimestele (institutsioonile alternatiivsete) kogukonnapõhiste teenuste arendamine (Lamb ja Bachrach 2001).

Viimastel aastatel on ka Eesti erihooldekandes aset leidnud suured muudatused: paljud vanades mõisahoonetes tegutsenud hooldekodud suleti ning sajad psüühikahäiretega inimesed said uued elamispinnad asulate keskustes või nende läheduses. Seejuures on uutes kohtades klientide arv endisest oluliselt väiksem. Euroopa struktuurifondide toetuse kasutamisega on Eesti võtnud kohustuse järgida nii ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni kui ka deinstitutsionaliseerimise põhimõtteid (Sotsiaalministeerium 2014). Seega peavad kogukonda elama asunud inimestele pakutavad tugiteenused toetama nende iseseisvust ja osalemist kogukonna elus.

Personaalse taastumise käsituse kohaselt on toetamise eesmärk parandada inimese heaolu nii emotsionaalsel, psühholoogilisel kui sotsiaalsel tasandil (Slade jt 2017). Tegevuse aluspõhimõteteks on isikukesksus, enesejuhtimise edendamine, individuaalne lähenemine, terviklik inimesekäsitus, jõustamine, tugevuste ülesleidmine, lootuse ja vastutuse edendamine ja austus inimese suhtes (Drake ja Whitley 2014).

Personaalne taastumine (erinevalt kliinilisest taastumisest) hõlmab elu mõtestamist ja uute eesmärkide leidmist selleks, et inimene tuleks toime haigusest tingitud raskustega. See on aga sügavalt isiklik ja ainukordne protsess. Taastumist toetavad inimeste kogemuslood ja oma identiteedi uuesti üles ehitamine ja piirangutega leppimine ning nendega toimetuleku õppimine (Den Hollander ja Wilken 2015).

Uurimuse korraldus

Minu magistritöö eesmärk oli mõista kogukonnas elamise teenust saavate psüühikahäiretega inimeste argipäeva. Eelkõige huvitas mind see, kuidas kogukonnas elamine toetab nende suutlikkust ise oma elu korraldada ja kogukonna elus osaleda.

Kasutasin kvalitatiivset lähenemist, andmekogumise meetoditeks olid argipäeva vaatlus ja poolstruktureeritud intervjuu. 2018. aasta veebruaris kuue päeva jooksul toimunud vaatlusel jälgisin töötajate interaktsiooni teenusekasutajatega igapäevaelu toimingutes. Vaatluse viisin läbi ühes linnas kogukonna keskel asuvas elamus, mis on eluruumiks seitsmele inimesele, keda toetasid kaks tegevusjuhendajat ja klienditööjuht². Vaatluse toimumise ajaks olid varem hooldekodus elanud inimesed elanud teenuseüksuses kaheksa kuud. Samal perioodil viisin läbi poolstruktureeritud intervjuud teenuseüksuse tegevusjuhendajate ja klienditööjuhiga. Uurisin, kuidas nad tõlgendavad argielus ettetulevaid olukordi ja mida peavad oluliseks oma klientide toetamisel.

Tulemused

Osalemine kogukonnas

Intervjuudest ja vaatlusest selgus, et teenust kasutavatel inimestel oli vähe omapoolset algatust, nad ootasid töötajate reaktsioone oma mõtetele ning vajasisid pidevat suunamist ja juhendamist. Sellest tulenevalt oli kogukonnas pakutavate võimaluste kasutamisel üldjuhul töötaja see, kes otsib tegevusi ning ergutab tegevustes osalema. Intervjuueeritavad rääkisid, et mõned kliendid ei julge üksi üritustel käia, teised isegi ei tule selle peale, et võiks osaleda sellistes tegevustes, mis toimuvad väljapool teenuse osutamise kohta. Toetudes Lambi ja Bachrachi (2001) ning Jonesi ja Flowesi (2008) uurimustele, on psüühikahäiretega inimeste passiivsus institutsioonis elamise iseloomulik pärand, sest inimesed on harjunud viibima kohas, kus nende elu juhivad töötajad. Üleminek kogukonnapõhistele teenustele on suur muutus. Oluline on korraldada läbimõeldud toetust, mis aitaks inimestel kogukonda sulanduda, kontakte luua, kohaneda ja elu väljakutsetega hakkama saada (Hamelin jt 2011).

Minu uurimus näitas, et inimesed, kes elasid nüüd kogukonnas, osalesid pigem vabaõhu- kui siseruumides korraldatavatel üritustel. Nii intervjuudest kui ka vaatlusest tuli välja, et nad võtsid osa linnapäevadest, adventitule süütamisest, vastlaliu laskmisest jm ettevõtmistest, mis on mõeldud kõigile linnakodanikele. Vähe aga osaleti linnarahva tegemistes, mis toimusid siseruumides. Sellistest tegevustest nimetati teatri ja raamatukogu külastamist ning

² AS Hooldekandeteenus on jagatud Harju, Kesk-Lõuna, Viru ja Lääne piirkonnaks, olenevalt piirkonna suuruselt on selles kaks või enam klienditööjuhti. Klienditööjuht tegeleb kvaliteedi küsimustega, on ekspert ja metoodik. Tema ülesanne on juhtida tegevusjuhendajaid ja teenust viisil, mis kannaks endas tänapäevaseid lähenemissuundi, ettevõtte väärtusi, oleks isikukeskne jne – autor.

osalemist pikaajalisel kaitstud töö teenusel. Enamasti suheldi inimestega, kellega puututi kokku teenust saades, nt kaasklientide ja töötajatega.

Nii vaatlusest kui ka intervjuudest selgus, et inimeste kogukonnas osalemine väljendus eelkõige pikaajalisel kaitstud töö teenusel käimises. Inimestel oli palju vaba aega, seda sisustatakse televiisori vaatamise, muusika kuulamise, uinakute või järgmise toidukorra ootamisega. Intervjuudest selgus, et klienditöötajad ei olnud otsinud naabruskonnast huvitegevusi, milles osalevad teisedki kohalikud elanikud (spordisaal, koorilaul, aeroobika, rahvatantsuring jm). Nad leidsid, et rohkem võiks olla selliseid erivajadustega inimestele mõeldud üritusi nagu puuetega inimeste laulupidu või paraolümpia. Mõningaid huvitegevusi on püütud pakkuda oma eluruumides.

Klientide huvid ja soovid tegevusplaanis

Slade jt (2017) ütlevad, et taastumise toetamisel on oluline leida mõtestatud tegevusi, edendada suhteid teiste inimestega ning pakkuda vastastikust toetust, sest see aitab inimestel tõlgendada oma kogemusi, määratleda enda sotsiaalset rolli ning kujundada positiivset identiteeti.

Tuleb kindlaks teha, millised on inimese huvid, mida ta hea meelega teeks ning kuidas saaks tema soove arvestades koostada nädalaplaani, milles on inimese enda valitud ja just talle olulised tegevused. Inimese huve aitab välja selgitada igale kogukonnas elamise teenuse kliendile koostatav isiklik tegevusplaani, samas ei oska klienditöö spetsialistid pahatihti inimeste unistusi arvestavaid eesmärke seada.

Den Hollander ja Wilken (2015) ütlevad,

et psüühikahäirega inimesele koostatud isiklik tegevusplaani aitab tal säilitada tegevuste struktuuri ja omada ülevaadet oma elust ka siis, kui ta ei suuda selgelt mõelda (korraga palju keerulisi ülesandeid, ravimite tingitud kõrvalnähtude, mäluprobleemide). Klienditööjuht rääkis, et tegevusplaani koostades on oluline lähtuda inimese tugevustest, unistustest ja soovidest. Ta rõhutas, kui tähtis on kaasata klient tegevusplaani koostamisse ja eesmärkide sõnastamisse. Samas arvasid tegevusjuhendajad, et tegevusplaani aitab arendada eeskätt neid oskusi, millega inimene hästi toime ei tule (hügieen, raha kasutamine, kodused toimetused). Võib nõustuda, et enesehooldusega toimetuleku parandamine on oluline, samas tuleks teistes eluvaldkondades keskenduda kliendi tugevuste arendamisele. Positiivse identiteedi loomine aitab inimesel näha end väljaspool haigust ja see on taastumise toetamisel esmatähtis (Schränk jt 2012).

Tegevusjuhendajate sõnul on tegevusplaani koostamine keeruline, sest teenusekasutajad ei ole eesmärkide püstitamisest huvitatud, mistõttu neid otseselt ei kaasatagi. Samas peeti oluliseks, et inimesele meeldiks tema tegevusplaani ja seepärast arutatakse tegevused koos läbi. Kliendi kaasamine temaga toimuvasse on vajalik, sest teemad, olukorrad ja soovid, mis ühe jaoks on olulised, ei pruugi teise jaoks seda olla, sest ainult inimene ise määrab oma väärtused (Slade jt 2017). Tuleks leida selline tegevusplaani koostamise viis, mis oleks ka kliendile huvitav ja kõnetaks teda.

Tegevusplaani koostamine eeldab, et klient ja töötaja teevad tihedat koostööd, koos pannakse kirja inimese oskused, kogemused ja võimalused, millele edaspidi

³ Üksuse moodustasid kümme inimest, kellest seitse elasid majas, kus vaatlus toimus, ja kolm eemal asuvas korteris – autor.

toetuda (Duncan jt 2003). Leamy jt (2011) uuringus osalenud rõhutasid, et lähenemised, mille puhul uuritakse inimeste tugevaid külgi, eesmärgi, väärtusi ja ravieelistusi, aitavad neil tunda end võimekamadena ning vaadata tulevikku lootusrikkamalt. Taastumiskogemusega inimesed on kirjeldanud seda protsessi kui elumuutvat kogemust, mille käigus leiad elule uuesti mõtte ja suudad ise oma elu juhtida (Williams jt 2015; Law ja Morrison 2014).

Kliendi vastutus oma elu puudutavates toimingutes

Minu uurimusest tuli välja, et kogukonnas elanud psüühikahäiretega inimesed olid ebakindlad ja ootasid pea kõigis igapäevastes tegevustes klienditöötajate suunamist ja abi. Seetõttu on tööpäevad väga intensiivsed, sest toetada tuleb kümnet³ inimest korraga. Teenust kasutavate inimeste vastutus oma elu korraldamise eest oli vähene või olid nad sõltuvuses töötajast. Vaatluse käigus selgus, et töötajad saatsid neid asjaajamistel, toetasid ja kontrollisid söögitegemise juures, kuulasid muresid, suunasid hügieenitoiminguid, aitasid raha kasutamist planeerida ja poes käia. Intervjuueeritavad selgitasid, et näiteks raha kasutamisega seotud hirmud pärinevad varasematest halbadest kogemustest, kuigi kogukonnas elades ei ole sedalaadi halbu kogemusi juurde tulnud.

Hamelin jt (2011) metaanalüüsi tulemusel leiti, et enda eest hoolitsemise oskus, iseseisev toimetulek kogukonnas, kognitsioon ja ametialased oskused paranevad märkimisväärselt, kui psüühikahäirega inimene saab õppida tegelikest olukordadest. Seega näen, et üheks võimaluseks tasakaalu saavutada on kasutada meetmeid, mis järk-järgult suurendavad kliendi vastutust.

Teenusekasutajate vastutust saab suurendada väikeste sammude kaupa, mis on

märgitud tegevusplaanis nii, et inimene teab, mida ta võib teha ilma kokkulepeteta ja milliseid olukordi tuleks töötajatega eelnevalt arutada. Lisaks näen, et linnas elades on võimalik kasutada vabatahtlikke, kes vajadusel saadaksid inimesi asjaajamistel, toetaksid neid söögivalmistamisel või võtaksid nad kaasa mõnda huvitegevusse. Vabatahtlike kaasamise väärtus seisneb selles, et teenuseüksuse elanikud saavad võtta vastutuse, kui tutvustavad neile oma elukorraldust ja näitavad oma oskusi, suurendades nii ühtlasi oma iseseisvust. Samas märkavad vabatahtlikud ohtlikke olukordi ja oskavad neile reageerida (nt suhtluskonfliktid, ohud toidu kuumtöötusel). Selline klientide toetamine tähendaks töötaja järk-järgulist taandumist tegevustest, kus tema kohaolu pole hädavajalik. See eeldab ümbruskonnas elavate inimeste kaasamist, näiteks selliste ürituste korraldamist kogukonnas elamise teenusel olevate inimeste poolt, mis on huvitavad ja meeldivad nii psüühikahäiretega inimestele kui ka naabruskonna elanikele (Wilken jt 2014).

Kokkuvõte

Kogukonnas elamist kasutavad inimesed on saanud uued elukohad linnades. See on suur samm kvaliteetsema erihooletandeteenuse suunas, kuid teenuse osutamise olemuse ning lähtekohtade muutmisel ja rakendamisel on veel pikk tee käia. Institutsioonist kogukonda liikunud inimesed vajavad mitmeid toetusmeetmeid, et passiivsetest inimestest, kes sõltuvad pidevast kõrvalisest juhendamisest, saaksid iseseisvad ühiskonna liikmed.

Minu uurimus näitas, et kasutamata on veel mitmed kogukondlikud ressursid, võimalused ja teenused ning seda, et klienditöö tegijad vajavad lisateadmisi klientide personaalse taastumise toetamiseks. **S**

Viidatud allikad

- Bullock, C. C., Mahon, M. J.** (2017). Introduction to Recreation Services for People with Disabilities (4. tr). Sagamore Publishing.
- Den Hollander, D., Wilken, J. P.** (2015). Kuidas klientidest saavad kodanikud. DUO kirjastus.
- Drake, R. E., Whitley, R.** (2014). Recovery and Severe Mental Illness: Description and Analysis. *The Canadian Journal of Psychiatry*, 59(5), 236–242. <https://doi.org/10.1177/070674371405900502>.
- Duncan, B. L., Miller, S. D., Sparks, J. A., Claud, D. A., Reynolds, L. R., Brown, J., Johnson, L. D.** (2003). The Session Rating Scale: Preliminary Psychometric Properties of a „Working” Alliance Measure. *Journal of Brief Therapy* 3 (1) 10.
- Fakhoury, W., Priebe, S.** (2007). Deinstitutionalization and reinstitutionalization: major changes in the provision of mental healthcare. *Psychiatry*, 6 (8), 313–316. <https://doi.org/10.1016/j.mpps.2007.05.008>.
- Hamelin, J. P., Frijters, J., Griffiths, D., Condillac, R., Owen, F.** (2011). Metaanalysis of deinstitutionalisation adaptive behaviour outcomes: Research and clinical implications. *Journal of Intellectual and Developmental Disability*. 36 (1), 61–72. <https://doi.org/10.3109/13668250.2010.544034>.
- Jones, K., Flowes, A. J.** (2008). Total institutions. Teoses: Johnson, J., DeSouza, C. (toim) Understanding Health and Social Care, 103–106. www.open.edu/openlearn/ocw/pluginfile.php/638332/mod_resource/content/1/chapter13.pdf. (15.04.2019).
- Lamb, H. R., Bachrach, L. L.** (2001). Some Perspectives on Deinstitutionalization. *Psychiatric Services*, 52(8), 1039–1045. <https://doi.org/10.1176/appi.ps.52.8.103937>.
- Law, H., Morrison, A. P.** (2014). Recovery in Psychosis: A Delphi Study With Experts by Experience. *Schizophrenia Bulletin*, 40(6), 1347–1355. <https://doi.org/10.1093/schbul/sbu047>.
- Leamy, M., Bird, V., Boutillier, C. L., Williams, J., Slade, M.** (2011). Conceptual framework for personal recovery in mental health: systematic review and narrative synthesis. *British Journal of Psychiatry*, 199 (06), 445–452. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.110.083733>.
- Neufeld, G. R.** (1977). Deinstitutionalization Procedures. *AAESPH Review*, 2 (1), 15–23. <https://doi.org/10.1177/154079697700200104>.
- Nirje, B.** (1999). How I came to formulate the Normalization principle. Teoses: Flynn R. J., Lemay, R. (toim), A Quarter-Century of Normalization and Social Role Valorization: Evolution and Impact. Ottawa: Les Presses de l'Université d'Ottawa, 17–50. <http://books.openedition.org/uop/2474>. (15.04.2019).
- Primeau, A., Bowers, T. G., Harrison, M. A., Xu Xu** (2013). Deinstitutionalization of the Mentally Ill: Evidence for Transinstitutionalization from Psychiatric Hospitals to Penal Institutions. *Comprehensive Psychology*, 2. <https://doi.org/10.2466/16.02.13.CP.2.2>.
- Salisbury, T. T., Killaspy, H., King, M.** (2016). An international comparison of the deinstitutionalisation of mental health care: Development and findings of the Mental Health Services Deinstitutionalisation Measure (MENDit). *BMC Psychiatry*, 16. <https://doi.org/10.1186/s12888-016-0762-4>.
- Schrank, B., Bird, V., Rudnick, A., Slade, M.** (2012). Determinants, selfmanagement strategies and interventions for hope in people with mental disorders: Systematic search and narrative review. *Social Science & Medicine*, 74 (4), 554–564. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.11.008>.
- Scott, W. R.** (2013). Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities. SAGE Publications.
- Slade, M., Oades, L. G., Jarden, A.** (2017). Wellbeing, Recovery and Mental Health. Cambridge University Press.
- Sotsiaalministeerium** (2014). Erihoolekande arengukava aastateks 2014–2020. www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_regevused/Sotsiaalhoolekanne/Puudega_inimetele/erihooolekande_arengukava_2014-2020.pdf. (15.04.2019).